

* Consulta *

NS

WOLMAR DO NASCIMENTO MARTINS

IDADE: 48 PESO: 123 ALTURA: 1,59 PROFISSÃO: motorista (manobrista)
SINTOMAS: contato ao acordar; vômito; refluxo. sonne rede

QUEIXAS: simult

MEDICAMENTOS: HAS / maldonina, slozok, tejet (aspiratothine),
Arginina, Aclodipina, Apynolina, Espirilactona, Glifage, megalina

MÉDICO: Dr. Ivan Macedo / Saccena. William D3;

EXERCÍCIO FÍSICO: não;

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: frut. JANTAR: S tarde

HORA QUE DORME: 00h 01h

HORA QUE ACORDA: 5h 6h.

COCHILHO () SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: ruiz.

BANHEIRO: 8x 5x 4x noite

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 310elh.

SPO2: 56%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim.

dm / colesterol

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA

() ENDÓCRINA

() CARDÍACA

HAS / Dissecf

() ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS

Dissecf Aorta 2mm internado - um / 100

cardiologista Dr. Pedro Lucine / Dr. Kerbu cirurgião (triperu)

Use a elevador - ITU persistente

14/11 P= 5 - 15cmH₂O

23 APE 2 só rampa.

mauc. BMC - nasal - m.

Oriento a limpeza e retorno em

15d.

30/11 Conseguiu ir a academia, melhorou sono

23 refluxo, m este modo pl o banheiro.

P= 10 média / Percentil 12.5cmH₂O.

IAH= 1.0

m. de uso: 4h35'

15/03/24 P= 10,6 (mediana) / Percentil: 12,5cmH₂O

IAH= 0,5

m de uso: 3h58'

Natacha

12/04/24 P= 10,6cmH₂O

IAH= 1.0

m. de uso: 3h50'

luc

17/10/24

P=10,8 cm H₂O

IAH= 1,1 e/h

m. de uso: 4h 17'

fuga: 10,8 lpm

Não utilizou todos os dias

Notada

24/01

25

P= 10,8 cm H₂O

IAH= 0,9 e/h

m. de uso: 4h 52'

fuga= 18 lpm

(2ª)

Folga

7-22m (trabalha)

00:00 chega em casa

(3ª)

Folga

7-22m

22/00 trabalha no centro

espiritista

trabalha a noite.

4ª folga acadêmica todos os dias.

Nome: WOLMAR DO NASCIMENTO MARTINS

Data de Nascimento: 29-3-1974

IMC: 48,88

Sexo: Masculino

Data do exame: 07-06-2023

Peso: 118 kg

Altura: 1,59 m

Médico: DR. PEDRO DUCCINI TRINDADE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-06-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 540,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 110,0 e 116,0 minutos. O tempo total de sono foi de 410,5 min, eficiência de 75,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,3%; estágio N2: 74,9%; estágio N3: 4,1%; sono REM: 19,6%. O índice de despertares foi de 68,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia-hipopnéia total foi de 110,5/hora, sendo 77 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 374 hipopnéias. A SpO2 média foi de 84% e a mínima de 56%, permanecendo 61,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 105 bpm e NREM de 56 - 106 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 110,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=56%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

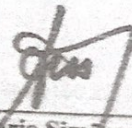
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Receituário

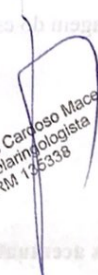
SAO JOSE DOS CAMPOS, 10 de agosto de 2023.

Sr. Wolmar do Nascimento Martins

Prescrição:

SOLICITO AVALIAÇÃO PARA USO DE CPAP
IAH 110/HORA

Att


Dr. Ivan Senis Cardoso Macedo
Otorrinolaringologista
CRM 135338

Ivan Senis Cardoso Macedo (CRM 135338)

Nome: WOLMAR DO NASCIMENTO MARTINS

Data de Nascimento: 29-3-1974

IMC: 46,68

Sexo: Masculino

Data do exame: 07-06-2023

Peso: 118 kg

Altura: 1,59 m

Médico: DR. PEDRO DUCCINI TRINDADE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07/06/2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 540,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 110,0 e 116,0 minutos. O tempo total de sono foi de 410,5 min, eficiência de 75,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,3%; estágio N2: 74,9%; estágio N3: 4,1%; sono REM: 19,6%. O índice de despertares foi de 68,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 110,5/hora, sendo 77 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 374 hipopnéias. A SpO2 média foi de 84% e a mínima de 56%, permanecendo 61,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 105 bpm e NREM de 56 - 106 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 110,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=56%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

... em horas